

VARIANTA A

1. Cataracta*:

1 E

- a. Reprezintă pierderea progresivă a transparenței corneei
- b. Evoluția are caracter reversibil
- c. Cataractele dobândite pot fi: congenitale, traumatice, medicamentoase
- d. Cataracta zonulară: opacitățile sunt localizate la nivelul nucleului
- e. Cataractele medicamentoase: cel mai frecvent se asociază cu corticosteroizii administrați sistemic

2. Trichiiazisul*:

2A

- a. Reprezintă o maldirecționare a cililor palpebrali, astfel încât aceștia privesc cu vârful lor spre globul ocular
- b. Se asociază cu febra fânului și astmul bronșic
- c. Reprezintă o depigmentare prematură a cililor palpebrali
- d. Reprezintă scăderea numărului de cili palpebrali, sau chiar pierderea acestora
- e. Toate afirmațiile sunt false

3. Sindromul de ochi uscat*:

3B

- a. Aprecierea secreției lacrimale se face prin intermediul testului Seidel
- b. Tratament: substituția lacrimilor prin administrarea de lacrimi artificiale
- c. Tratament: strict chirurgical
- d. Aprecierea secreției lacrimale se face prin timpul de rupere al filmului conjunctival
- e. Toate afirmațiile sunt false

4. Anizometropia*:

4B

- a. Nu reprezintă un factor de risc pentru ambliopie
- b. Reprezintă o diferență de refracție între cei doi ochi
- c. Nu reprezintă o diferență de refracție între cei doi ochi
- d. Se corectează strict chirurgical
- e. Se corectează doar cu lentile de contact dure

5. Următoarele afirmații sunt adevărate*:

5 B

- a. Prin microcorneea se înțelege o corneea cu diametrul mai mic de 6mm
- b. Prin microcorneea se înțelege o corneea cu diametrul mai mic de 9mm
- c. Corneea plană se asociază cu miopie
- d. Prin megalocorneea se înțelege o corneea cu diametrul mai mare de 15mm
- e. Megalocorneea se asociază cu glaucoma primar cu unghi închis

6. Histologic, retina este formată din*:

6 B

- a. 2 straturi
- b. 10 straturi
- c. 5 straturi
- d. 7 straturi
- e. Nici una din variantele de mai sus

7. În miopie*:

7 A

- a. razele paralele, venit de la infinit se focalizează înaintea retinei
- b. razele paralele, venite de la infinit se focalizează în spatele retinei
- c. razele paralele, venite de la infinit se focalizează la nivelul retinei
- d. axul ocular este prea scurt
- e. corecția se realizează cu lentil cilindrice

8. Pterigionul*:

8 D

- a. Este o afecțiune cu caracter malign
- b. Se prezintă sub forma unei excrescențe palpebrale
- c. Nu necesită tratament
- d. Are formă triunghiulară: baza la plica semilunară și vârful spre corneea
- e. Reprezintă o acumulare de pigment melanice la nivelul conjunctivei

9. Keratitele*:

9 B

- a. Reprezintă inflamații acute ale conjunctivei
- b. La examenul biomicroscopic se pot remarca leziuni corneene cu pierdere de substanță
- c. Nu se asociază congestia percheratică
- d. Keratita marginală se caracterizează prin infiltrate sau ulcere mici punctiforme localizate la distanță de limbul sclero-cornean
- e. Reprezintă opacifierea cristalinului

10. Ocluzia de venă centrală a retinei*:

10 D

- a. Produce ischemie retiniană totală, deoarece vasele retiniene sunt terminale și nu există posibilitatea dezvoltării circulației colaterale
- b. Debută prin pierderea treptată și nedureroasă a vederii la ambii ochi
- c. Tratament: antibioterapie
- d. Nu reprezintă o urgență oftalmologică
- e. Toate afirmațiile sunt corecte

11. Vitrosul:

11 BCD

- a. Este un țesut conjunctiv vascularizat
- b. Este bogat în acid hialuronic
- c. Umple spațiul dintre cristalin și retina
- d. Hemoragiile vitreene se însoțesc de scăderea acuității vizuale
- e. Corpii flotanți în vitros apar doar la tineri

12. Următoarele afirmații sunt adevărate:

12 CDE

- a. Valoarea normală a presiunii intraoculare este de aproximativ 5,5mmHg
- b. În glaucomul cronic cu unghi închis, presiunea intraoculară este normală
- c. Analogii de prostaglandină reprezintă una dintre substanțele active ce compun colirele antiglaucomatoase
- d. Tratamentul glaucomului congenital este exclusiv chirurgical
- e. Iridotomia cu laser argon produce una sau mai multe orificii de comunicare între polul anterior și polul posterior

13. Retina:
- 13 BCE
- a. Este alcătuită din 4 straturi
 - b. În decolarea de retina, ecografia ocular arată o imagine în formă de litera "V"
 - c. Ocluzia de arteră centrală a retinei poate fi cauzată de emboli carotidieni proveniți cel mai frecvent din plăcile de aterom de la nivelul bifurcației carotidiene
 - d. Retinopatia diabetică este o macroangiopatie
 - e. Retinopatia diabetică proliferativă se caracterizează prin apariția neovaselor
14. Melanomul coroidian:
- 14 ABD
- a. Este o tumoră melanocitară malignă
 - b. Oftalmoscopic se observă o formațiune tumorală subretiniană, denivelată, de culoare maro-gri sau poate fi nepigmentată
 - c. Vârsta medie de diagnostic este 20 ani
 - d. Opțiuni terapeutice: tratament chirurgical
 - e. Opțiuni terapeutice: iridotomie laser
15. Mușchii extrinseci ai globului ocular sunt:
- 15 ABE
- a. Mușchiul drept superior
 - b. Mușchiul drept intern
 - c. Mușchiul oblic extern
 - d. Mușchiul oblic intern
 - e. Mușchiul oblic superior
16. Corneea:
- 16 ACDE
- a. Formează alături de sclera tunica externă a globului ocular
 - b. Este o tunică transparentă, bogat vascularizată
 - c. Prezintă 5 straturi
 - d. Este bogat inervată
 - e. Prezintă o față externă, convexă, în raport cu filmul lacrimal
17. Hipermetropia:
- 17 BC
- a. Razele paralele de la infinit, în absența acomodăției, se focalizează înaintea retinei
 - b. este cauzată de un ax ocular prea scurt
 - c. se corectează cu lentile convexe
 - d. se corectează cu lentile concave
 - e. se corectează cu lentil prismatice
18. Astigmatismul:
- 18 ABCE
- a. Reprezintă o tulburare de refracție determinată de existența mai multor axe cu puteri diferite la nivelul corneei
 - b. Astigmatism miopic simplu: $-0,75\text{Dcyl } 90^\circ$
 - c. Astigmatism hipermetropic compus: $+1,50\text{Dsf } +0,50\text{Dcyl}$
 - d. Astigmatism mixt : $-1,00\text{Dsf } -0,75\text{Dcyl } 100^\circ$
 - e. Se corectează cu lentile cilindrice
19. Examinarea corneei:
- 19 ABD
- a. Examenul biomicroscopic permite vizualizarea unei secțiuni transversale în grosimea corneei
 - b. Folosirea coloranților speciali evidențiază lipsa de substanță la nivelul corneei
 - c. Tehnici moderne: retinofotografia

- d. Microscopia speculară: aduce informații asupra numărului și formei celulelor stratului endotelial
- e. Pahimetria: evaluează grosimea sclerei

20. Keratoconul:

20
CDE

- a. Este o ectazie conică bilaterală , inflamatorie
- b. Corneea este mai groasă în zona central
- c. Corneea este mai subțire în zona central
- d. În vederea stopării evoluției se poate efectua cross-linking cu riboflavină
- e. Pentru stadiile mai avansate, singura opțiune terapeutică este transplantul de cornee

21. Clasificarea glaucoamelor:

21 CDE

- a. Glaucomul cu unghi deschis: PIO este normal
- b. Hipertensiunea intraoculară: discul optic și câmpu vizual prezintă modificări caracteristice
- c. Atacul de glaucom: PIO înregistrează o creștere bruscă
- d. Glaucomul congenital primitiv:este prezent de la naștere
- e. Glaucomul secundar al copilului: este produs de inflamații, tumori, traumatisme.

22. Retinopatia hipertensivă:

ACD

- a. Semnele cuprind: vasoconstricția arteriolară retiniană focală sau generalizată
- b. Semnele cuprind: vasodilatația arteriolară retiniană focală sau generalizată
- c. Semnele cuprind: ischemie cu apariția nodulilor cotoñoși
- d. Cuprinde modificări vasculare retiniene produse de presiunea arterială crescută
- e. Cuprinde modificări vasculare retiniene produse de presiunea arterial scăzută

23. Strabismul:

ACDE

- a. Este definit ca fiind o lipsă de aliniere de la paralelismul axelor vizuale
- b. Ortoforie= starea de dezechilibru a mușchilor oculo-motori
- c. Ortoforie=starea de echilibru a mușchilor oculo-motori
- d. Strabismele paralitice sunt cauzate fie de afectări musculare, fie de leziuni ale nervilor oculomotori
- e. În paralizii oculomotorii sunt întâlnite diplopia, falsa proiecție, tulburările reflexe.

24. Enoftalmia, cauze:

ABCD

- a. Fractura planșeului orbitei
- b. Malformații orbitare
- c. Diverse sindroame : Sd. Horner, Sd. Pancoast
- d. Traumatisme obstetricale
- e. Mărirea volumului grăsimii orbitare

25. Celulita orbitală:

ABD

- a. Este inflamația seroasă difuză a țesutului celulo-adipos al orbitei
- b. Subiectiv, pacientul prezintă: dureri orbitare, stare general alterată, cefalee, febră
- c. Obiectiv: enoftalmie axială unilaterală
- d. Complicații locale: panoftalmia
- e. Complicații locale: septicemie.

26. Gerontoxonul:

ADE

- a. Se mai numește arcul senil
- b. Este o opacitate concentrică, în centrul corneei

- c. Se însoțește de reacție inflamatorie
- d. Nu scade acuitatea vizuală
- e. Nu necesită tratament

27. Coroida:

BC

- a. Face parte din tunica externă a globului ocular
- b. Se întinde între nervul optic și ora seratta
- c. Face parte din tunica medie a globului ocular
- d. Anterior se continuă cu corneea
- e. Este avasculară

28. Retina:

ABC

- a. Reprezintă tunica internă a globului ocular
- b. Este tunica care are funcție fotoreceptoare
- c. Macula lutea reprezintă zona centrală a retinei
- d. Celulele bipolare reprezintă deutoneuronul căii vizuale
- e. Este avasculară

29. Aparatul lacrimal :

29 ACDE

- a. Este format din glandele lacrimale și căile lacrimale
- b. Glanda lacrimală principal este situată în porțiunea antero-medială a peretelui superior al orbitei
- c. Sacul lacrimal se află în grosimea pleoapei
- d. Canaliculele lacrimale pornesc de la nivelul punctelor lacrimale
- e. Canaliculul lacrimal superior se unește cu canaliculul lacrimal inferior și se deschid împreună în sacul lacrimal

30. Corecția cu lentil de contact:

30 ABE

- a. Permite vizualizarea mai bună a câmpului vizual periferic
- b. Oferă confort sporit la pacienții cu activități fizice la care ochelarii pot fi deranjanți
- c. Nu permit corecția anizometropiei
- d. Din punct de vedere al materialului se deosebesc: lentil de contact rigide gaz-impermeabile
- e. Există lentile care prezintă și dioptrii cilindrice

31. Ectropionul:

31 BCD

- a. Reprezintă o inversare (răsfrângere spre înăuntru) a marginii libere palpebrale
- b. Din punct de vedere etiologic, cuprinde formele: senilă, paralică, cicatricială, congenitală, mecanică
- c. Forma paralică apare în general datorită parezei periferice de nerv facial (VII)
- d. Tratamentul este întotdeauna chirurgical
- e. Tratamentul este simptomatic

32. Următoarele afirmații sunt adevărate:

ACE

- a. Dacriocistita reprezintă procesul inflamator al sacului lacrimal
- b. Dacrioadenita reprezintă procesul inflamator al sacului lacrimal
- c. Epifora este forma de lăcrimare excesivă care apare datorită imposibilității de drenare a lacrimilor
- d. Orice alterare calitativă sau cantitativă a secreției lacrimale duce la sindromul de ochi uscat
- e. Sindromul Sjogren poate duce la sindrom de ochi uscat

a filmului lacrimal

33. Conjunctivitele:

ABDE

- a. În conjunctivita bacteriana, conjunctiva este hiperemică, congestionată
- b. Conjunctivitele cu adenovirusuri sunt extrem de contagioase
- c. Tratamentul conjunctivitelor virale: coliruri miotice
- d. Conjunctivita vernală(primăvărată) are la bază o reacție de hipersensibilitate de tip I și IV
- e. În keratoconjunctivita Sicca elemental central îl reprezintă hiposecreția lacrimală sau evaporarea în exces a apei din filmul lacrimal

34. Traumatismele corneei:

epiteliul cornean

34 BC

- a. Eroziunile corneene sunt caracterizate prin pierderi de substanță din endoteliul cornean
- b. Cauzele eroziunilor corneene: corpi strărini, cili implantați defectuos, traumatisme
- c. Plăgile corneene penetrante: ochiul va fi hipoton
- d. Arsurile corneene se tratează strict chirurgical
- e. Ulcerul serpiginos: în lipsa tratamentului vindecarea este spontană

35. Cataractele:

ABCD

- a. În funcție de momentul apariției se clasifică în congenitale și dobândite
- b. Contuziile globului ocular pot duce la apariția cataractei traumatice
- c. Biometria reprezintă determinarea valorii dioptrice a cristalinului artificial ce urmează a fi implantat
- d. Tratamentul cataractei este strict chirurgical
- e. Operația de cataractă se efectuează doar în anestezie generală

36. Complicațiile intraoperatorii ale chirurgiei cataractei:

36 AD

- a. Ruptura capsulei posterioare a cristalinului
- b. Uveite
- c. Glaucom secundar
- d. Leziuni ale irisului sau corneei produse cu instrumentele chirurgicale
- e. Hifema postoperatorie

37. Prezbiopia:

37 BCE

- a. Reprezintă o tulburare patologică a acomodatiei
- b. Se manifestă prin scăderea amplitudinii de acomodatie
- c. Corecția se efectuează cu lentile convergente
- d. Corecția se efectuează cu lentile divergente
- e. Mecanismul prezbiopiei este dat de scăderea lentă a elasticității cristalinului

38. Orjeletul:

38 ACDE

- a. Se datorează infecției acute a unei glande Zeiss sau Moll cu stafilococ auriu
- b. Se datorează infecției acute a glandei lacrimale
- c. Simptomatologie: initial pacientul simte o senzație de greutate și tensiune în pleoapa afectată
- d. Tratament: se recomandă aplicarea locală de comprese calde
- e. Tratament: unguente antibiotice

39. Chalasionul:

39 ADE

- a. Este o afecțiune inflamatorie chistică a pleoapei
- b. Tegumentul care acoperă colecția palpebrală este lucios și tensionat

- c. Este asimptomatic dacă chistul lipogranulomatos este de dimensiuni mari
- d. Chisturi de dimensiuni mici: aplicarea locală de unguente oftalmice cu corticosteroizi
- e. Tratamentul de elecție al chalasioanelor de dimensiuni mari este chirurgical

40. Carcinomul cutanat bazocelular al pleoapei:

40 BCDE

- a. Este tumora benignă cel mai des întâlnită de la acest nivel
- b. Apare în special la persoanele în vârstă
- c. Poate afecta orice regiune topografică a pleoapei
- d. Tratamentul de bază îl reprezintă excizia chirurgicală
- e. Examenul histopatologic al piesei excizate este obligatoriu

41. Următoarele afirmații sunt adevărate:

41 ACD

- a. Ochiul privit global prezintă o putere de refracție de 64D
- b. Ochiul privit globat prezintă o putere de refracție de 24D
- c. Procesul de acomodatie este procesul prin care cristalinul se bombează și își crește puterea de refracție
- d. Pentru examinarea acuității vizuale se utilizează testul Snellen
- e. În practica oftalmologică se consideră că infinitul eset realizat pentru obiecte situate mai departe de 9m

42. Blefaritele cronice:

42 ADE

- a. Sunt inflamațiile marginii libere palpebrale
- b. Se dezvoltă la nivelul pleoapelor superioare
- c. Se dezvoltă la nivelul pleoapelor inferioare
- d. Din punct de vedere topografic se clasifică în blefarite anterioare, posterioare și mixte
- e. Blefarita cronică anterioară se asociază cu senzația de arsură la nivelul pleoapelor

43. Conjunctivita herpetică:

43 BDE

- a. Este apanajul infecției primitive cu virusul herpes simplex II
- b. Secreția conjunctivală este abundentă și întotdeauna seroasă
- c. Nu se asociază cu keratita herpetică
- d. Tratamentul etiologic se va face cu antivirale
- e. Tratament: se pot administra antiseptice de suprafață ocular

44. Factorii de risc în retinopatia diabetică:

44 BCDE

- a. Controlul metabolic bun
- b. Diabetul zaharat
- c. Anemia
- d. Nefropatia
- e. Obezitatea

45. În funcție de dispoziția opacităților în cristalin, cataracta legată de vârstă poate fi:

45 ABC

- a. Nucleară
- b. Subcapsulară posterioară
- c. Zonulară
- d. Subcapsulară anterioară
- e. Traumatică

46. Complicațiile postoperatorii tardive ale chirurgiei cataractei:

46 CDE

- a. Dehiscența zonulară
- b. Subluxația implantului de cristalin în cavitatea vitreană

- c. Opacifieera capsule posterioare (cataracta secundară)
- d. Uveita cronică
- e. Descentrarea tardivă a pseudofakului

47 BDE

47. Degenerescentă maculară legată de vârstă:
- a. Este o afecțiune degenerativă care afectează vitrosul
 - b. Simptomele tipice: alterarea vederii centrale, metamorfopsii
 - c. Fumatul nu reprezintă un factor de risc în apariția afecțiunii
 - d. Tratamentul include terapia medicamentoasă în fazele inițiale
 - e. De obicei nu apare la persoanele tinere

48 ACDE

48. Următoarele afirmații sunt false:
- a. Nervul optic este o porțiune a sistemului nervos periferic
 - b. Edemul discului optic rezultă din creșterea presiunii intracraniene
 - c. Edemul papilar nu poate fi observat la examenul fundului de ochi
 - d. Neuropatia optică inflamatorie nu se asociază cu pierderea bruscă a vederii
 - e. Nervul optic este o structură avasculară

49 ABD

49. Următoarele afirmații sunt adevărate:
- a. Contuziile oculare apar în urma traumatismelor cu obiecte ascuțite
 - b. Corpii străini intraoculari reprezintă o urgență oftalmologică
 - c. În plăgile perforante nu apare o soluție de continuitate în epiteliul afectat
 - d. Perforația traumatică a corneei se însoțește de durere vie, fotofobie, scăderea acuității vizuale.
 - e. Orice plagă penetrantă a globului ocular prezintă indicație absolute pentru enucleare.

50. Principalele cauze de exoftalmie unilaterală: Sau CDE

- a. Boala Basedow(la debut)
- b. Celulita orbitară
- c. Tumorală
- d. Rupturi de mușchi extraoculari
- e. Traumatică (hematom)

MERG TOATE
ABCDE

carte pagina 222